

# Depresion Mayor

## Manual del Terapeuta

*Basado en el modelo de Beck | Evidencia nivel A*

## 1. Descripcion del Trastorno

### 1.1 Criterios diagnosticos DSM-5

Presencia de 5 o mas de los siguientes sintomas durante al menos 2 semanas, representando un cambio respecto al funcionamiento previo. Al menos uno debe ser (1) estado de animo deprimido o (2) perdida de interes o placer.

- Estado de animo deprimido la mayor parte del dia, casi todos los dias
- Disminucion marcada del interes o placer en todas o casi todas las actividades
- Perdida o aumento significativo de peso sin hacer dieta, o cambio en el apetito
- Insomnio o hipersomnia casi todos los dias
- Agitacion o enlentecimiento psicomotor (observable por otros)
- Fatiga o perdida de energia casi todos los dias
- Sentimientos de inutilidad o culpa excesiva e inapropiada
- Dificultad para pensar, concentrarse o tomar decisiones
- Pensamientos recurrentes de muerte o ideacion suicida

### 1.2 Prevalencia y curso

- Prevalencia de vida: 15-17% en poblacion general
- Mas frecuente en mujeres (relacion 2:1)
- Inicio promedio: 25-30 anos, aunque puede aparecer a cualquier edad
- Curso episodico: 50% tendra un segundo episodio; con cada episodio aumenta el riesgo de recurrencia
- Alta comorbilidad: trastornos de ansiedad (50%), abuso de sustancias, enfermedades medicas

### 1.3 Diagnostico diferencial

| Diagnostico | Diferenciacion clave |
|-------------|----------------------|
|-------------|----------------------|

|                    |                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trastorno bipolar  | Evaluar episodios previos de mania o hipomania; importante antes de iniciar tratamiento   |
| Duelo normal       | En duelo, el estado de animo fluctua; en depresion es persistente y generalizado          |
| Distimia (TDP)     | Sintomas menos intensos pero cronicos (mas de 2 anos); puede coexistir con episodio mayor |
| Hipotiroidismo     | Descartar causa medica; solicitar TSH ante depresion atipica o resistente                 |
| Depresion inducida | Evaluar sustancias y medicamentos (benzodicepinas, betabloqueantes, esteroides)           |

## 2. Modelo Cognitivo de Beck

### 2.1 La Triada Cognitiva

Beck identifica tres patrones cognitivos negativos que mantienen la depresion:

1. VISION NEGATIVA DE SI MISMO: 'Soy un fracasado', 'Soy inutil', 'No valgo nada'
2. VISION NEGATIVA DEL MUNDO: 'Todo es dificil', 'Nada sale bien', 'El mundo es injusto'
3. VISION NEGATIVA DEL FUTURO: 'Nada va a mejorar', 'No tiene sentido intentarlo'

### 2.2 Distorsiones cognitivas frecuentes en depresion

| Distorsion                      | Definicion                             | Ejemplo                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Pensamiento dicotomico</b>   | Todo o nada, blanco o negro            | <i>'O lo hago perfecto o soy un fracasado'</i> |
| <b>Catastrofizacion</b>         | Anticipar el peor resultado posible    | <i>'Si me critican, sera el fin'</i>           |
| <b>Filtraje negativo</b>        | Enfocarse solo en lo negativo          | <i>'Hice todo bien pero cometi un error'</i>   |
| <b>Lectura mental</b>           | Asumir lo que otros piensan            | <i>'Se que les aburro cuando hablo'</i>        |
| <b>Personalizacion</b>          | Atribuirse culpa innecesaria           | <i>'Si mi hijo esta mal es por mi culpa'</i>   |
| <b>Generalizacion excesiva</b>  | Sacar conclusiones amplias de un hecho | <i>'Siempre me pasa lo mismo'</i>              |
| <b>Descalificacion positivo</b> | Restar valor a los logros propios      | <i>'Eso que logre no cuenta, era facil'</i>    |

## 2.3 Ciclo de mantenimiento de la depresion

PENSAMIENTO NEGATIVO -> Estado de animo deprimido

-> Reduccion de actividad y retraimiento social

-> Perdida de reforzadores positivos

-> Confirmacion de pensamientos negativos -> MAS DEPRESION

## 3. Estructura del Protocolo

### 3.1 Duracion y formato

- Sesiones: 16 a 20 sesiones individuales (puede extenderse en casos severos)
- Frecuencia: semanal (quincenal en fase de mantenimiento)
- Duracion por sesion: 50-60 minutos
- Formato: 3 fases — Activacion conductual / Reestructuracion cognitiva / Prevencion de recaidas

### 3.2 Mapa de sesiones

| N  | Titulo                         | Objetivos                                     | Tecnicas principales                     |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1  | Evaluacion y psicoeducacion    | Establecer alianza, explicar modelo cognitivo | Entrevista, psicoeducacion, BDI-II       |
| 2  | Formulacion y metas            | Formulacion del caso, acordar objetivos       | Triada cognitiva, metas SMART            |
| 3  | Activacion conductual I        | Aumentar actividades placenteras y de dominio | Registro de actividades, programacion    |
| 4  | Activacion conductual II       | Consolidar programacion de actividades        | Jerarquia de actividades, experimentos   |
| 5  | Activacion conductual III      | Trabajar evitacion y retraimiento social      | Exposicion gradual, planificacion social |
| 6  | Identificacion de pensamientos | Reconocer pensamientos automaticos negativos  | Registro de pensamientos, cadena ABC     |
| 7  | Reestructuracion cognitiva I   | Cuestionar pensamientos automaticos           | Cuestionamiento socratico, evidencias    |
| 8  | Reestructuracion cognitiva II  | Trabajar distorsiones cognitivas              | Registro de 5 columnas, alternativas     |
| 9  | Reestructuracion cognitiva III | Identificar y modificar creencias intermedias | Flecha descendente, supuestos            |
| 10 | Creencias nucleares I          | Explorar esquemas y creencias core            | Identificacion de esquemas, historia     |
| 11 | Creencias nucleares            | Cuestionar y modificar creencias              | Registro de datos positivos,             |

|    |                         |                                               |                                        |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
|    | II                      | nucleares                                     | dialogo                                |
| 12 | Resolucion de problemas | Entrenar en resolucion efectiva de problemas  | Tecnica D'Zurilla, plan de accion      |
| 13 | Habilidades sociales    | Mejorar asertividad y comunicacion            | Entrenamiento asertivo, role-playing   |
| 14 | Regulacion emocional    | Ampliar repertorio de afrontamiento emocional | Mindfulness, aceptacion, autocompasion |
| 15 | Consolidacion           | Revisar logros y consolidar aprendizajes      | Resumen del proceso, fortalezas        |
| 16 | Prevencion de recaidas  | Plan de mantenimiento y manejo de recaidas    | Señales de alarma, plan de accion      |

## 4. Tecnicas de Intervencion

### 4.1 Psicoeducacion

- Explicar la depresion como un trastorno tratable, no una debilidad de caracter
- Presentar el modelo cognitivo-conductual: pensamientos-emociones-conductas
- Normalizar los sintomas y su impacto en el funcionamiento
- Explicar la logica del tratamiento: activar primero, luego cuestionar pensamientos

Metafora recomendada — El motor en frio:

'Cuando estamos deprimidos, es como un auto con el motor frio: no arranca bien. Muchas veces esperamos sentirnos bien PARA hacer cosas, pero en la depresion funciona al reves: hay que HACER cosas para empezar a sentirse mejor. La activacion conductual es como precalentar el motor antes de exigirlo.'

### 4.2 Activacion Conductual

- Principio central: la depresion reduce la conducta, y la conducta reducida mantiene la depresion
- Primer paso: monitoreo de actividades y estado de animo (registro horario)
- Clasificar actividades en: placer (P), dominio/logro (D), rutina (R)
- Programar actividades graduales, comenzando por las de menor esfuerzo
- Trabajar explicitamente la evitacion conductual y el retraimiento social

**IMPORTANTE:** La activacion conductual precede a la reestructuracion cognitiva. No esperar que el paciente 'se sienta con ganas'. La accion precede a la motivacion. Frase clave: 'Actua opuesto a la depresion: si quiere quedarte en cama, levántate'

### 4.3 Registro de Pensamientos Automaticos (Columnas de Beck)

Progresion de registros:

- 2 columnas: situacion | pensamiento automatico
- 3 columnas: situacion | PA | emocion y nivel (0-10)
- 5 columnas: situacion | PA | emocion | evidencias pro/contra | pensamiento alternativo
- 7 columnas (avanzado): agrega creencia en PA inicial y en alternativo, y emocion final

### 4.4 Reestructuracion Cognitiva

Preguntas socraticas para la depresion:

- Que evidencia tienes de que ese pensamiento es cierto?
- Hay evidencias en contra?
- Que tan probable es en realidad que ocurra lo que temes?
- Que le dirias a un amigo que pensara lo mismo?
- Que seria lo mas realista que podrias pensar en esta situacion?
- Como te sentiras respecto a esto dentro de 1 año?
- Cual es el impacto de creer este pensamiento? Y de cuestionarlo?

### 4.5 Activacion Conductual de Dominio y Placer

Pedir al paciente que registre sus actividades durante una semana y que califique:

P = Placer (0-10): cuanto disfruto la actividad

D = Dominio (0-10): cuanto logro o control sintio al hacerla

Muchos pacientes deprimidos subestiman el placer y logro que obtienen.

Comparar las predicciones con la experiencia real es un experimento conductual clave.

### 4.6 Tecnica de Resolucion de Problemas

- Paso 1: Definir el problema de forma concreta y especifica
- Paso 2: Generar el mayor numero posible de soluciones (sin evaluar aun)
- Paso 3: Evaluar pros y contras de cada solucion
- Paso 4: Elegir la mejor solucion o combinacion
- Paso 5: Planificar su implementacion (quien, cuando, como)
- Paso 6: Evaluar los resultados y ajustar si es necesario

## 4.7 Prevencion de Recaidas

- Identificar senales de alerta personales (primeros sintomas que aparecen al inicio de un episodio)
- Elaborar un plan de accion escrito: que hacer cuando aparecen esas senales
- Revisar y practicar las tecnicas aprendidas de forma preventiva
- Programar sesiones de seguimiento: al mes, a los 3 y 6 meses
- Normalizar la posibilidad de recaida como parte del proceso, no como fracaso total

## 5. Consideraciones Clinicas

### 5.1 Evaluacion de riesgo suicida

SIEMPRE evaluar ideacion suicida en la primera sesion y en cada sesion.

Preguntar directamente: 'Has tenido pensamientos de hacerte dano o de no querer seguir viviendo?'

Evaluar: frecuencia, intensidad, plan concreto, acceso a medios, intentos previos, factores protectores.

Ante riesgo moderado-alto: derivacion urgente a psiquiatria / guardia hospitalaria.

### 5.2 Obstaculos frecuentes

- Pasividad extrema: comenzar con tareas minimas (5 minutos de actividad)
- Pensamiento todo-o-nada en las tareas: reforzar cualquier intento, por pequeno que sea
- Desesperanza sobre el tratamiento: normalizar mejora lenta, mostrar graficos de progreso
- Comorbilidad ansiosa: priorizar segun cual trastorno genera mas deterioro funcional
- Episodios severos: considerar farmacoterapia de primera linea antes o durante la TCC

### 5.3 Indicadores de progreso

- Reduccion en el PHQ-9 o BDI-II (al menos 50% de reduccion sintomatica)
- Aumento en frecuencia e intensidad de actividades placenteras
- Mayor flexibilidad cognitiva: mas pensamientos alternativos espontaneos
- Restablecimiento de rutinas: sueno, alimentacion, actividad fisica
- Reenganche con vinculos sociales y actividades significativas

## 6. Referencias Bibliograficas

Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. F. y Emery, G. (1979). Cognitive therapy of depression. Guilford Press. (Trad. castellano: Terapia cognitiva de la depresion, Desclee de Brouwer.)

Martell, C. R., Dimidjian, S. y Herman-Dunn, R. (2010). Behavioral activation for depression: A clinician's guide. Guilford Press.

Maero, F. y Jose Quintero, P. (2015). Tratamiento breve de activacion conductual para depresion. Akadia Editorial.

American Psychiatric Association (2013). DSM-5. APA Publishing.

Barlow, D. H. (Ed.) (2014). Manual clinico de trastornos psicologicos. Piramide.